

DOCUMENTO DE VISÃO

SICA — Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos

Versão Protótipo | Junho de 2026

1. Identificação do Documento

Este documento registra a visão geral do sistema SICA, consolidando contexto, objetivos, escopo e as principais decisões que orientam o desenvolvimento do projeto acadêmico.

Campo	Informação
Nome do Projeto	SICA — Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos
Versão	Protótipo
Data	Junho de 2026
Status	Em desenvolvimento

Autores		
RA	Nome	E-mail
0030482511010	Caio Domingues	caio.bernardino@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511039	Emanuel Almeida	emanuel.almeida@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511020	Gustavo Carvalho	gustavo.santos46@aluno.cps.sp.gov.br
0030482511002	Paulo Guilherme	paulo.silva45@aluno.cps.sp.gov.br

2. Introdução

2.1 Contexto do Projeto

A área da saúde está cada vez mais necessitando das novas tecnologias para facilitar seus processos e garantir uma boa experiência ao cliente. As maiores clínicas ainda operam com agendamento manual e sistemas de administração de informações isolados, que acabam gerando muito retrabalho, comunicação ruim e insatisfação dos clientes e dos próprios trabalhadores. Para isso, o SICA foi criado, pensando em uma aplicação mobile que permitisse o agendamento e a gestão administrativa financeira da clínica.

2.2 Motivação

A fragmentação de informações e a dependência de processos manuais ainda caracterizam boa parte das clínicas brasileiras. A ausência de uma ferramenta unificada provoca:

- Dificuldade dos pacientes em localizar clínicas e horários disponíveis;
- Falta de lembretes e confirmações automáticas, gerando faltas e buracos nas agendas;
- Sobrecarga administrativa sobre profissionais que poderiam dedicar esse tempo ao atendimento;

2.3 Cenário Atual

O agendamento de consultas ocorre principalmente por telefone, WhatsApp ou sistemas de gestão isolados que não se comunicam entre si. O paciente precisa contatar cada clínica individualmente, muitas vezes em horário comercial, sem acesso a disponibilidade em tempo real. Médicos e administradores dependem de planilhas ou softwares legados, sem integração com notificações automáticas ou histórico do paciente.

A proposta atualmente se encontra em seu processo de desenvolvimento acadêmico, onde estão concluídos os artefatos de análise: personas, requisitos, casos de uso, diagrama de classes e telas prototipadas dos quatro perfis de usuários (Cliente, Médico, Administrador e Gestor). A implementação será realizada conforme a stack que foi escolhida – Expo (React Native) na camada front-end e Oracle como Banco de Dados.

2.4 Problema Identificado

A ausência de uma única plataforma que possibilite ao paciente marcar consultas por conta própria, ao médico observar seu cronograma de maneira estruturada e ao gestor acompanhar o desempenho financeiro e operacional do consultório, tudo em uma única aplicação móvel.

3. Objetivo do Sistema

3.1 Objetivo Principal

Desenvolver uma aplicação mobile que simplifique o processo de agendamento médico, centralize informações de clínicas, médicos e pacientes, e ofereça ferramentas de gestão administrativa e financeira para todos os perfis de usuário envolvidos.

3.2 Benefícios Esperados

- Redução do tempo necessário para agendar uma consulta;
- Diminuição de faltas por meio de lembretes e confirmações automáticas;
- Centralização do histórico de agendamentos e documentos médicos do paciente;
- Maior controle administrativo da agenda médica;
- Suporte a dependentes, permitindo que um responsável gerencie a saúde de toda a família.

3.3 Resultado Esperado

Ao final do projeto, espera-se uma aplicação funcional atendendo a quatro perfis: Cliente/Paciente, Médico, Administrador e Gestor, com fluxos de agendamento completos, painel administrativo, gestão de dependentes, envio de documentos médicos e dashboard financeiro, desenvolvida em Expo com banco de dados Oracle.

4. Visão Geral da Solução

4.1 Descrição Resumida do Sistema

O SICA é uma aplicação mobile que foi construída em Expo (React Native) e backend integrado ao Oracle Database. As interfaces do sistema são separadas por perfis individuais e são eles: Interface do Cliente, Interface do Médico, Interface do Administrador e Interface do Gestor.

4.2 Como o Sistema Resolve o Problema

- O cliente acessa o aplicativo da clínica contratante, visualiza os médicos disponíveis, filtra por especialidade, escolhe o profissional e o horário e confirma o agendamento diretamente pelo app, sem necessidade de ligação ou mensagem;
- O médico visualiza sua agenda consolidada, vê histórico do paciente e compartilha documentos de saúde;
- O administrador gerencia o cadastro dos médicos, controla agendas e faz reagendamentos quando necessário;
- O gestor faz acompanhamento de indicadores financeiros, verifica assinaturas e recebe alertas de erros e inadimplência.

4.3 Diferenciais da Solução

- Gestão de dependentes: o titular consegue agendar consultas para outros membros da família;
- Encaminhamentos digitais: envio e validação de documentos médicos no fluxo do agendamento;
- Mensagens automáticas: lembretes antes da consulta;
- Indicadores financeiros com detalhes de receita, despesa, estimativas e comparativos de performance;
- Arquitetura em microsserviços: upgrades isolados para cada módulo sem interromper o funcionamento geral;
- Regulamentação pela Lei Geral de Proteção de Dados: criptografia TLS 1.3, logs inalteráveis e armazenamento seguro de anexos

5. Escopo do Projeto

5.1 Dentro do Escopo

Funcionalidades principais:

- Agendamento de consultas com seleção de especialidade, médico, data e horário;
- Gestão de dependentes (cadastro, edição, remoção e associação a agendamentos);
- Envio e validação de encaminhamentos médicos (.pdf, .png, .jpg);

- Cancelamento e reagendamento de consultas;
- Notificações automáticas de lembrete;
- Painel administrativo com controle de médicos e agenda;
- Painel do médico com agenda, prontuário e envio de documentos;
- Dashboard financeiro com receitas, despesas, previsões e relatórios;
- Gerenciamento de assinaturas de clínicas;
- Monitoramento com logs, alertas de falha e inadimplência;
- Autenticação com suporte a 2FA.

Limites do sistema:

- O sistema abrange o ciclo completo de agendamento até a confirmação da consulta;
- O controle financeiro cobre receitas e despesas da plataforma SICA (assinaturas de clínicas), não a gestão financeira interna de cada clínica;
- Documentos médicos gerados pelos médicos, como receitas e encaminhamentos, são hospedados em plataformas de terceiros especializadas, o sistema disponibiliza apenas um atalho de acesso a essas plataformas, não armazenando nem processando esse tipo de documento internamente;

5.2 Fora do Escopo

- Teleconsulta (videochamada entre médico e paciente);
- Prontuário eletrônico completo (o sistema registra apenas documentos anexados);
- Processamento de pagamentos de consultas entre pacientes e clínicas;
- Integração com sistemas legados de gestão hospitalar.

6. Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse no Sistema
Clínicas médicas	Cliente pagante	Automatizar agendamentos e reduzir faltas
Pacientes / Clientes	Usuário final	Agendar consultas de forma rápida e autônoma
Médicos	Usuário interno	Visualizar agenda organizada e gerenciar documentos
Administradores de clínica	Usuário interno	Controlar cadastros, agendas e assinaturas
Gestor da plataforma	Usuário operacional	Monitorar desempenho, finanças e sistema
Equipe de desenvolvimento	Técnico	Desenvolver, testar e manter a plataforma

7. Perfis de Usuário

7.1 Cliente (Persona Primária)

Identificada na figura de Maria Eduarda Oliveira, 38 anos, pessoa responsável pela coordenação da saúde dos membros da família. Faz vários agendamentos, precisa ter visibilidade clara de horários, lembretes automáticos e atendimento de dependente.

Necessidades: Agendamento simples, busca inteligente, agenda de compromissos, recebimento das receitas online e perfis familiares.

Objetivos: realizar agendamentos de forma rápida e autônoma, acompanhar compromissos de saúde de toda a família em um único lugar e receber lembretes automáticos para não perder consultas.

7.2 Administrador (Persona Secundária)

Representado pela persona Jane Domingues, 32 anos. Responsável por organizar as operações de agendamento da clínica. Sofre com trabalho manual, buracos na agenda e demora na resposta de pacientes.

Necessidades: painel administrativo completo, controle de agendas, gerenciamento de médicos e da assinatura da clínica.

Objetivos: manter a agenda da clínica sempre atualizada, evitar conflitos de horário e reduzir o trabalho manual no gerenciamento de médicos e consultas.

7.3 Médico (Persona Secundária)

Identificado na figura de Rafael Almeida, 45 anos. Necessidade de ter sua agenda organizada corretamente, confirmação de agendamentos e dados do paciente.

Necessidades: Agenda visível, dados do paciente, receitas online e envio de encaminhamentos, notificações de cancelamento.

Objetivos: ter visibilidade clara da própria agenda, reduzir faltas de pacientes por meio de confirmações, acessar informações completas do paciente antes do atendimento e enviar documentos médicos de forma prática.

7.4 Gestor (Persona Secundária)

Identificada na figura de Gerson Almeida, 20 anos. Pessoa responsável por administrar e manter a plataforma, inclusive monitorando a parte técnica e financeira.

Necessidades: Painel de gestor completo, dados sobre as assinaturas e pagamento, previsão de receita e custos, gestão de usuários administrativos e de sistemas.

Objetivos: garantir o funcionamento estável da plataforma, manter controle financeiro sobre assinaturas e pagamentos das clínicas e antecipar problemas por meio de alertas e previsões de desempenho.

8. Problemas e Oportunidades

Problema	Impacto	Oportunidade
Agendamentos manuais (telefone / WhatsApp)	Sobrecarga administrativa e erros de comunicação	Autoatendimento digital com confirmação instantânea
Falta de lembretes automáticos	Alta taxa de faltas e buracos na agenda	Notificações push automáticas
Informações descentralizadas de pacientes	Dificuldade de acompanhamento e risco de erros	Perfil unificado com histórico e dependentes
Gestão financeira sem visibilidade em tempo real	Decisões baseadas em dados desatualizados	Dashboard com previsões e relatórios
Falta de rastreabilidade de encaminhamentos	Risco de perda de documentos médicos	Upload seguro com armazenamento em bucket isolado

9. Necessidades do Negócio

9.1 Demandas Organizacionais

- Digitalizar o processo de agendamento eliminando dependência de canais manuais;
- Centralizar o cadastro de médicos e agenda em um único sistema;
- Viabilizar o modelo de negócio SaaS por meio de assinaturas de clínicas.

9.2 Necessidades Operacionais

- Garantir que um horário nunca seja agendado em duplicidade (consistência ACID);
- Manter disponibilidade de 99,9% (SLA) para não comprometer atendimentos;
- Enviar notificações de lembrete de forma confiável;
- Registrar logs auditáveis de todas as ações sobre dados de saúde (LGPD).

9.3 Metas Estratégicas

- Posicionar o SICA como plataforma de referência para clínicas de pequeno e médio porte;
- Escalar para suportar até 10.000 acessos simultâneos via escalamento horizontal;
- Gerar relatórios financeiros que apoiem decisões sobre planos de assinatura;
- Atingir conformidade total com a LGPD desde a primeira versão.

10. Funcionalidades de Alto Nível

#	Funcionalidade	Descrição
F01	Agendamento de Consultas	Fluxo completo: especialidade, médico, data/horário, dados pessoais e confirmação. Suporte a agendamento para dependentes.
F02	Gestão de Dependentes	Cadastro, edição e remoção de dependentes vinculados ao titular. Associação de agendamentos e visualização separada por perfil.
F03	Envio de Encaminhamentos	Upload de arquivos médicos (.pdf, .png, .jpg) como pré-requisito para consultas específicas, com validação de formato e armazenamento seguro.
F04	Painel do Médico	Visualização de agenda, acesso a dados e prontuário do paciente, envio de documentos médicos e cancelamento de consultas.
F05	Painel Administrativo	Gerenciamento de médicos, controle de agendas, reagendamento e cancelamento de consultas, edição de dados da clínica e gestão de assinatura.
F06	Dashboard Financeiro	Receitas, despesas, lucro/prejuízo, previsões mensais e comparativos de desempenho. Geração de relatórios detalhados.
F07	Gerenciamento de Assinaturas	Listagem de assinaturas ativas, detalhes de pagamento por clínica, alteração de plano, cancelamento e reativação.
F08	Monitoramento e Alertas	Status do sistema, logs de auditoria, alertas de falha técnica, inadimplência e variações financeiras relevantes.
F09	Notificações Automáticas	Lembretes push 2 dias antes de cada consulta. Notificações de cancelamento e reagendamento.
F10	Autenticação e Segurança	Login com 2FA, criptografia TLS 1.3, controle de acesso por perfil e logs imutáveis.

11. Requisitos Gerais

11.1 Requisitos Funcionais Principais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Visualizar consultas agendadas	Média
RF04	Listar médicos disponíveis da especialidade selecionada	Alta
RF08	Selecionar data e horário para consulta	Alta
RF11	Confirmar agendamento após validação dos dados	Alta
RF12	Enviar encaminhamento médico com validação de formato	Alta
RF13	Receber alertas de falhas no sistema	Alta
RF17	Cancelar agendamento	Baixa
RF19	Notificação de lembrete 2 dias antes da consulta	Média
RF20	Cadastrar dependentes	Média
RF28	Visualizar receita total (Gestor)	Alta
RF35	Visualizar assinaturas ativas (Gestor)	Alta
RF40	Acessar painel administrativo	Alta

11.2 Requisitos Não Funcionais Principais

ID	Tipo	Descrição
RNF01	Segurança	Criptografia de dados sensíveis com TLS 1.3 ou superior
RNF03	Confiabilidade	Disponibilidade de 99,9% (SLA)
RNF04	Usabilidade	Interface conforme WCAG 2.1 com suporte a leitores de tela
RNF05	Escalabilidade	Suporte a 10.000 acessos simultâneos via escalamento horizontal
RNF08	Confiabilidade	Consistência transacional ACID — sem overbooking
RNF10	Segurança	Logs de auditoria imutáveis conforme LGPD
RNF11	Manutenibilidade	Arquitetura em microsserviços
RNF14	Segurança	Autenticação em dois fatores (2FA)

11.3 Restrições Técnicas

- Plataforma exclusivamente mobile (Android e iOS via Expo);
- Banco de dados Oracle como solução de persistência;
- Pacote de instalação não deve exceder 150 MB;
- Backend estruturado em microserviços.

12. Regras de Negócio

12.1 Políticas

- Cada horário de consulta só pode ser ocupado por um paciente; reservas duplicadas são bloqueadas;
- O cancelamento de uma consulta deve atualizar automaticamente a disponibilidade da agenda;
- Consultas que exigem encaminhamento não podem ser confirmadas sem envio e validação do arquivo;
- Assinaturas inadimplentes geram alerta para o gestor e podem ter acesso suspenso.

12.2 Restrições

- Arquivos de encaminhamento aceitos: .pdf, .png, .jpg. Outros formatos são rejeitados;
- O titular pode gerenciar dependentes e vincular agendamentos a cada um;
- O acesso ao painel administrativo é restrito a perfis Administrador ou Gestor.

12.3 Validações Gerais

- Dados obrigatórios no agendamento: nome completo, CPF e data de nascimento;
- O CPF deve ser validado por algoritmo antes do envio ao servidor;
- Datas e horários só podem ser selecionados se disponíveis na agenda do médico;
- Relatórios financeiros só podem ser gerados por usuários com perfil Gestor.

13. Premissas

13.1 Hipóteses Consideradas

- As clínicas parceiras dispõem de estrutura mínima de internet para uso do sistema;
- Os usuários possuem smartphones Android ou iOS com acesso à internet;
- Os médicos cadastrados possuem CRM válido e especialidade definida;
- As clínicas aceitarão o modelo de assinatura para acesso à plataforma.

13.2 Dependências Externas

- Serviço de notificações push (ex.: Firebase Cloud Messaging);
- Serviço de armazenamento em bucket para anexos médicos;
- Infraestrutura Oracle para persistência de dados.

13.3 Condições Assumidas

- O escopo está restrito à versão mobile — versão web não está prevista no MVP;
- A geração de previsões financeiras depende de dados históricos acumulados de uso;
- A conformidade com a LGPD é responsabilidade tanto da equipe de desenvolvimento quanto das clínicas operadoras.

14. Restrições

14.1 Tecnológicas

- Desenvolvimento restrito ao ecossistema Expo (React Native) para suporte multiplataforma;
- Banco de dados obrigatório é o Oracle, sem previsão de migração nesta versão;
- Tamanho máximo do pacote de instalação: 150 MB.

14.2 Financeiras

- Projeto acadêmico sem orçamento dedicado para infraestrutura paga;
- Serviços de terceiros devem ser avaliados em versões gratuitas ou de desenvolvimento.

14.3 Operacionais

- Equipe composta por quatro desenvolvedores com dedicação parcial (carga acadêmica);
- Prazo limitado ao calendário acadêmico do semestre 2026-1.

14.4 Legais

- O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018);
- Dados de saúde são classificados como dados sensíveis e exigem tratamento especial;
- O armazenamento e acesso a laudos e prontuários devem seguir normas do CFM.

15. Riscos Iniciais

Risco	Tipo	Prob.	Impacto	Mitigação
Complexidade de integração entre microsserviços	Técnico	Alta	Alto	Definir contratos de API documentados e usar testes de integração
Conflito de agendamentos simultâneos (overbooking)	Técnico	Média	Alto	Implementar lock no banco de dados com consistência ACID
Não conformidade com LGPD	Legal	Baixa	Alto	Aplicar criptografia, controle de acesso e logs desde o início
Limitação de tempo da equipe acadêmica	Operacional	Alta	Médio	Priorizar MVP e dividir responsabilidades por módulo
Dificuldade de adoção pelas clínicas	Negócio	Média	Alto	Validar usabilidade com personas e testes com usuários reais
Instabilidade de APIs externas	Técnico	Baixa	Médio	Implementar fallbacks e tratamento de erro para cada integração

16. Integrações Externas

Integração	Finalidade	Observação
Notificações Push	Lembretes automáticos de consulta (RF19) e alertas de sistema	Ex.: Firebase Cloud Messaging (FCM)
Storage / Bucket	Armazenar anexos médicos com controle de acesso por token temporário (RNF06)	Ex.: AWS S3, Google Cloud Storage
Banco de Dados Oracle	Persistência de todos os dados com suporte a transações ACID	Requisito técnico definido pelo projeto
Serviço de 2FA	Autenticação em dois fatores (RNF14)	Ex.: TOTP (Google Authenticator) ou SMS

17. Visão Arquitetural Inicial

17.1 Arquitetura Geral

O sistema adota arquitetura em microsserviços no backend, com cada módulo funcional operando de forma independente. O frontend é um aplicativo Expo (React Native) que se comunica com os serviços via APIs REST.

17.2 Componentes Principais

Componente	Responsabilidade
App Mobile (Expo/React Native)	Interface do usuário para todas as personas. Consome APIs REST dos microsserviços.
Serviço de Agendamento	Gerencia consultas, disponibilidade de horários e consistência transacional (anti-overbooking).
Serviço de Usuários	Autenticação, cadastro, 2FA, controle de acesso por perfil e gestão de dependentes.
Serviço Financeiro	Gestão de assinaturas, pagamentos, relatórios e previsões financeiras.
Serviço de Notificações	Envio de push notifications via FCM para lembretes e alertas.
Serviço de Documentos	Upload, validação e armazenamento seguro de anexos médicos em bucket isolado.
Serviço de Monitoramento	Coleta de logs de auditoria, alertas de falha e status do sistema.
Banco de Dados Oracle	Persistência centralizada com suporte a transações ACID.

17.3 Infraestrutura Prevista

- Backend em microsserviços com deploy independente por serviço;
- Banco Oracle como solução de persistência principal;
- Bucket de armazenamento para documentos médicos com tokens temporários;
- Escalamento horizontal para suportar picos de 10.000 acessos simultâneos;
- Backups automáticos incrementais a cada 6 horas com RTO máximo de 1 hora.

18. Critérios de Sucesso

Indicador	Meta	Como Medir
Disponibilidade do sistema	99,9% (SLA)	Monitoramento contínuo com alertas
Agendamentos sem overbooking	Zero conflitos	Testes de concorrência e logs transacionais
Cobertura de testes unitários	Mínimo 80%	Relatório de cobertura do framework de testes
Conformidade LGPD	100% dos dados sensíveis criptografados	Auditoria de segurança antes do deploy
Geração de relatórios financeiros	Em até 10s	Testes funcionais com massa de dados realista
Tamanho do pacote de instalação	Menor que 150 MB	Verificação no processo de build do Expo

19. Roadmap Inicial

19.1 MVP (Versão 1.0)

- Cadastro e autenticação de usuários (com 2FA);
- Fluxo completo de agendamento de consultas (RF01 ao RF14);
- Gestão de dependentes (RF20 ao RF27);
- Notificações automáticas de lembrete (RF19);
- Painel administrativo básico (gerenciar médicos e agenda);
- Visualização de agenda pelo médico;
- Dashboard financeiro com receitas, despesas e assinaturas;
- Monitoramento básico com logs e alertas.

19.2 Próximas Fases — Versão 1.1

- Relatórios financeiros com previsões e comparativos de período;
- Envio de documentos médicos (receitas, encaminhamentos) pelo médico;
- Refinamento do painel do gestor com previsões automáticas;
- Melhorias de acessibilidade (WCAG 2.1 completo).

19.3 Evoluções Previstas — Versão 2.0

- Portal web complementar ao aplicativo mobile;
- Teleconsulta (videochamada médico-paciente);
- Prontuário eletrônico completo;
- Inteligência artificial para otimização de agendas e previsões financeiras.

20. Glossário

Termo / Sigla	Definição
SICA	Sistema Integrado para Clínicas e Agendamentos — nome do projeto.
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima viável com as funcionalidades essenciais.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) — legislação brasileira de proteção de dados pessoais.
TLS	Transport Layer Security — protocolo criptográfico para comunicação segura em rede.
2FA	Two-Factor Authentication — autenticação em dois fatores, camada adicional de segurança no login.
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — propriedades que garantem confiabilidade em transações de banco de dados.
SLA	Service Level Agreement — acordo de nível de serviço que define a disponibilidade mínima garantida.
RTO	Recovery Time Objective — tempo máximo aceitável para restauração do sistema após falha.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — diretrizes de acessibilidade para interfaces digitais.
CFM	Conselho Federal de Medicina — órgão regulador da medicina no Brasil.
Expo	Framework baseado em React Native para desenvolvimento mobile multiplataforma.
Microserviços	Padrão arquitetural em que o sistema é dividido em serviços independentes por domínio funcional.
Bucket	Serviço de armazenamento em nuvem para arquivos, como anexos médicos.
Overbooking	Situação em que dois pacientes são agendados para o mesmo horário — prevenida pelo sistema.
Push Notification	Notificação enviada ao dispositivo móvel mesmo com o aplicativo fechado.
Persona	Representação fictícia de um perfil de usuário real, usada para orientar decisões de design.
Dependente	Pessoa cadastrada por um titular para a qual ele pode realizar agendamentos (ex.: filho, pai idoso).
Gestor	Usuário responsável pela gestão financeira e operacional da plataforma SICA.
Administrador	Usuário responsável pela operação de uma clínica específica dentro da plataforma.

21. Referências

21.1 Documentos Relacionados

- Personas do Projeto SICA — docs/personas.md (repositório GitHub)
- Requisitos Funcionais e Não Funcionais — docs/requisitos.md
- Casos de Uso: Administrador, Médico, Cliente, Gestor e Sistema — docs/casos de uso/
- Diagrama de Classes — README.md (seção Diagrama de Classes)

21.2 Links

- Repositório GitHub: <https://github.com/InsaneCaio/eng-soft-2026-1>
- Protótipo Cliente (Google Stitch):
<https://stitch.withgoogle.com/projects/11329770657792360424>
- Protótipo Administrador (Google Stitch):
<https://stitch.withgoogle.com/projects/3155227529588405910>
- Protótipo Médico (Google Stitch):
<https://stitch.withgoogle.com/projects/3557494496187097419>
- Protótipo Gestor (Google Stitch):
<https://stitch.withgoogle.com/projects/11630288415312253588>

21.3 Normas e Legislação

- Lei Geral de Proteção de Dados — Lei 13.709/2018 (LGPD)
- WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines, W3C
- Resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) sobre prontuário eletrônico
- ISO/IEC 25010 — Modelo de qualidade de software

21.4 Diagramas

- Diagrama de Classes (Mermaid) — disponível no README do repositório
- Diagrama de Casos de Uso por ator — disponível em docs/casos de uso/